

간질성 방광염, 즉 방광통증증후군(IC/BPS)은 방광 또는 골반 통증, 압박감, 불편함과 함께 잦고 급한 소변 욕구가 지속되는 만성 질환입니다 — 감염 없이 나타납니다. 불편함은 방광이 차면서 심해지고, 소변을 보고 나면 완화되는 경향이 있습니다. 완전한 치료법은 없지만, 적절히 관리하면 증상을 크게 줄일 수 있습니다.

이 질환에 대하여

IC/BPS는 감염이 아니며 전염되지 않습니다. 증상은 사람마다 다르고, **증상 악화(flare)** 기간과 비교적 잠잠한 기간이 반복됩니다. 주요 특징:

- 방광 또는 골반의 통증, 압박감, 불편함
- 낮과 밤에 걸쳐 잦고 급한 소변 욕구
- 방광이 찼수록 **불편함이 심해지고** 소변 후 완화된
- 특정 음식, 스트레스, 또는 월경 주기에 의해 유발되는 증상 악화

원인

정확한 원인은 밝혀지지 않았습니다. 방광 점막 과민, 신경 과민, 그리고 **긴장되고 과활성화된 골반저**가 복합적으로 관여하는 것으로 알려져 있습니다. 여러 요인이 관여하므로 치료도 여러 방법을 병행합니다.

용어 설명

IC/BPS

간질성 방광염 / 방광통증증후군 — 감염 없이 나타나는 방광 통증과 절박뇨.

증상 악화(Flare)

음식이나 스트레스 등으로 유발되는 일시적 증상 악화 시기.

배제 진단

감염 등 다른 원인을 배제한 후 내리는 진단.

골반저 물리치료

긴장된 골반 근육을 이완시키는 물리치료.

방광 내 주입 치료

얇은 도뇨관을 통해 진정 효과가 있는 약물을 방광 안에 넣는 치료.

Hunner 병변

일부 환자의 방광 벽에서 발견되는 특이 병변으로 직접 치료 가능.

방광경 검사

얇은 카메라로 방광 내부를 관찰하는 검사.

완치가 가능한가요? IC/BPS는 대개 장기적인 질환이지만, 치료를 병행하고 유발 요인을 파악하면 대부분 실질적인 증상 완화를 얻을 수 있습니다. 목표는 증상 악화 횟수와 강도를 줄여 일상생활을 유지하는 것입니다 — 자신에게 맞는 방법을 찾는 데 시간이 걸릴 수 있으니 인내심을 가지세요.

진단 방법

단일 검사법은 없습니다. 다른 원인을 배제한 후 증상을 바탕으로 진단합니다:

- 감염 및 혈뇨 확인을 위한 **소변 검사**
- 증상 병력 청취와 **방광 일기** 작성
- 필요 시 Hunner 병변 확인을 위한 **방광경 검사**

치료 방법 (단계별)

- 1 **자기 관리** — 음식 유발 요인을 파악하고, 스트레스와 수면을 관리하며, 부드러운 방광 훈련을 시행합니다.
- 2 **골반저 물리치료** — 긴장된 근육을 이완시킵니다 (강한 케겔 운동은 오히려 악화될 수 있습니다).
- 3 **약물 치료** — 경구 약물과 **방광 내 주입 치료**를 병행합니다.
- 4 **표적 및 고급 치료** — Hunner 병변 직접 치료 또는 난치성의 경우 신경 자극 치료.

생활 관리

- 흔한 유발 요인: **커피, 차, 알코올, 감귤류, 토마토, 매운 음식** — 하나씩 제거 후 다시 섭취하며 자신의 유발 요인을 파악하세요.
- **증상 악화 대처 계획**을 세워 두세요 (휴식, 온찜질, 물 섭취 증가, 자극 없는 음식).
- 스트레스와 긴장된 골반저는 증상을 악화시킵니다 — 가벼운 움직임과 이완이 도움이 됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열, 오한, 또는 등/옆구리 통증 (감염 가능성)
- 새로 나타난 **혈뇨**
- 조절되지 않는 증상 악화 또는 소변을 볼 수 없는 경우

기억할 세 가지

1. IC/BPS는 감염이 **아닌** 방광·골반 통증과 절박뇨가 특징인 만성 질환이지만, 잘 관리할 수 있습니다.
2. 자기 관리와 유발 요인 조절, 골반저 물리치료, 약물 및 주입 치료, 표적 치료를 병행합니다.
3. 음식·스트레스 유발 요인을 파악하고 증상 악화 대처 계획을 세우세요. 새로운 혈뇨, 발열, 또는 옆구리 통증은 즉시 확인이 필요합니다.